31. L'APPAREIL GÉNITAL FÉMININ

DURÉE : 06:15 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Dans cette vidéo, nous explorons en profondeur le développement de l'appareil génital féminin, en commençant par la formation des canaux de Wolff et de Müller, et leur impact sur la structure reproductive. L'accent est mis sur la relation uro-génitale qui diffère entre l'homme et la femme, en mettant en lumière la création de l'utérus et des trompes. Nous approfondissons également le rôle des ligaments large et ovarien, ainsi que l'importance de la santé rénale dans la régulation hormonale et la fertilité. La vidéo aborde la continuité fasciale dans le pelvis et comment des anomalies comme les fibromes peuvent influencer l'ensemble de la dynamique corporelle, fournissant des informations cruciales pour les praticiens en ostéopathie et en développement embryonnaire.

L'APPAREIL GÉNITAL FÉMININ

1. DUCTUS MÉSONEPHROTIQUE (CANAL DE WOLFF) ET PARANÉPHROTIQUE (CANAL DE MÜLLER)

Le **canal de Wolff**, également appelé **ductus mésonephrotique**, est le premier canal qui apparaît chez l'embryon.

Chez l'homme, ce canal descend et est intégré entre les testicules pour former le **canal éjaculateur**. En revanche, le canal de Müller reste comme vestige et contribue à la formation du cœur de la prostate.

Chez la femme, la situation est inversée :

- Le canal de Wolff se différencie en **organes de Gardner**, qui sont des vestiges.
- Le canal de Müller, par fusion, devient l'**utérus** et les **trompes**.

DÉVELOPPEMENT URO-GÉNITAL

La relation **uro-génitale** est fondamentale. Chez l'homme, le canal épididymaire, le canal déférent et le canal éjaculateur se forment à partir de cette relation.

Chez la femme, ce développement ne se produit pas de la même manière. Le canal de Müller se réunit vers la ligne centrale pour former l'utérus.

Les organes de Gardner représentent les vestiges du canal de Wolff chez la femme. Le canal éjaculateur est orienté vers la base, et plus on s'écarte, plus il formera l'utérus. Moins on s'écarte, plus le vestige sera le **tricule prostatique**.

2. LE LIGAMENT LARGE ET LES LIGAMENTS OVARIENS

Chez l'homme et la femme, le **péritoine pariétal postérieur** se concentre pour former le **ligament large**, ainsi que les petits ligaments ovariens et les ligaments ronds.

C'est le même tissu, mais avec des concentrations différentes. Ce péritoine pariétal postérieur va former l'utérus chez la femme.

Chez l'homme, ce mouvement n'existe pas, et il ne reste qu'une concentration de péritoine.

3. LE REIN ET LA SURRÉNALE

Le rein est situé en dessous de la **surrénale**, séparés par une capsule. Cela signifie qu'une **ptose rénale** n'entraîne pas de ptose surrénalienne.

Ils sont séparés par un fascia appelé la **capsule de Glisson**. Le rein nécessite un espace graisseux.

Chez les femmes très minces, une ptose du rein peut entraîner des irrégularités menstruelles et une fertilité réduite. **Redynamiser un rein**, c'est également redynamiser sa fertilité.

DÉVELOPPEMENT EMBRYONNAIRE DU REIN

Au départ, chez un petit embryon, les reins sont énormes, tout comme le foie. Cela rappelle le développement du cerveau, qui est très développé par rapport au tronc au début.

Ces proportions évoluent au cours du développement. Le foie joue un rôle important dans le développement des surrénales.

C'est la première fois qu'une **différenciation structurelle** entre l'homme et la femme est observée, liée au développement plus important des glandes qui créent le **tubercule de Müller**.

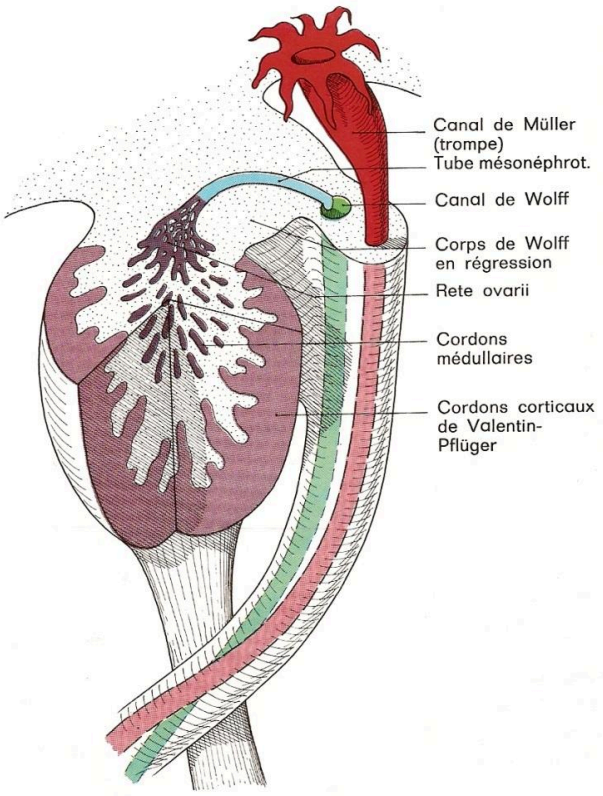


Fig. 1. — *Vue schématique de la différenciation ovarienne au moment de la régression du corps de Wolff.*

FIG. — Différenciation ovarienne

4. DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME DE MÜLLER (5ÈME SEMAINE)

À la cinquième semaine, le système sous le côté commence à se développer, redonnant toute la puissance au rein.

Le cerveau influence la mise en place du cœur, qui à son tour met en place la **diaphragmatisation**, le foie, les surrénales, les gonades et la crête.

Le canal de Müller se développe beaucoup plus fortement chez la femme pour créer un canal pur, qui se rejoint pour former l'utérus.

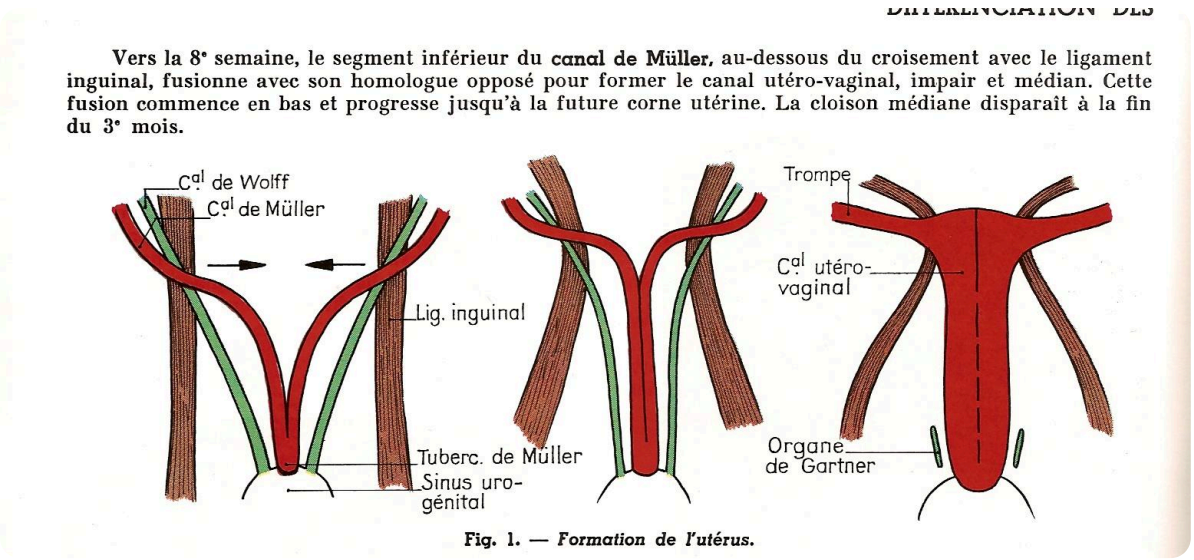


FIG. — Formation utérus embryonnaire

Chez l'homme, le développement est moins prononcé, et ce qui reste en bas du canal de Müller constitue le cœur de la prostate.

DESCENTE TESTICULAIRE

La **descente testiculaire** est due à la vitesse de croissance différenciée au niveau du **gubernaculum**, qui ralentit et tire tout le système.

Cette continuité fasciale entre l'utérus et toute la partie du fascia, de la peau et du petit bassin est essentielle.

5. CONTINUITÉ FASCIALE ET INFLUENCE DES STRUCTURES

On observe bien l'utérus, les ligaments, les ovaires et la **cavité péritonéale**.

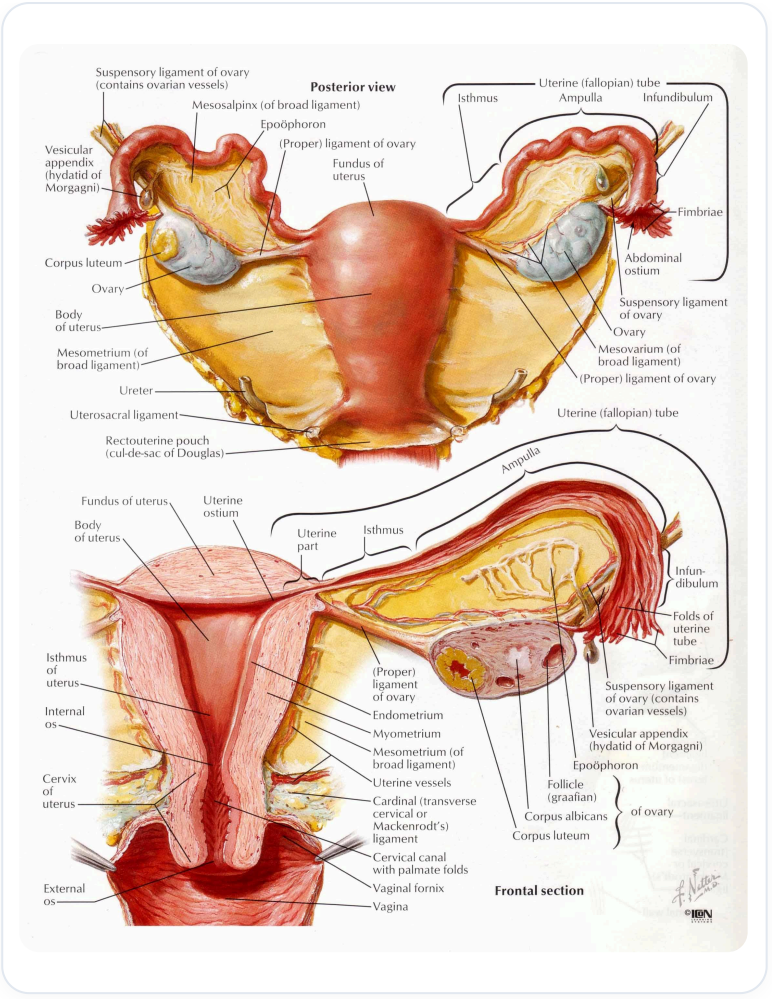


FIG. — Appareil reproducteur féminin

En soulevant l'utérus avec des pinces, on constate que tout bouge.

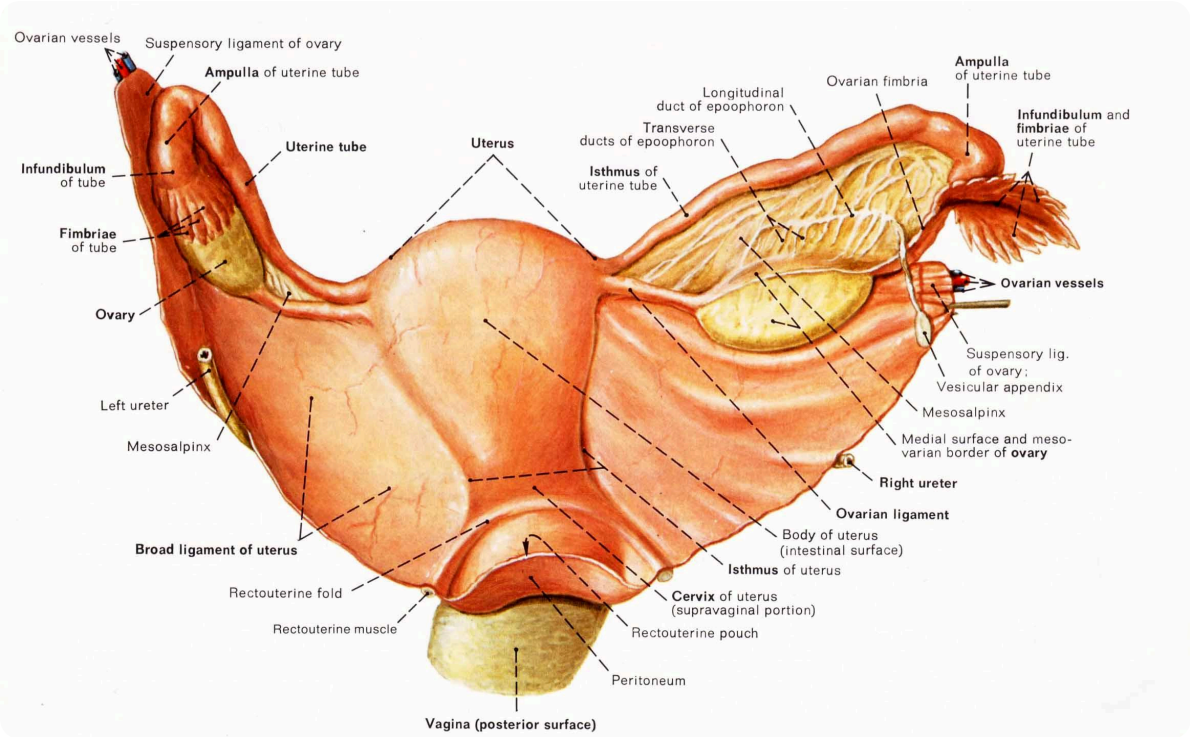


FIG. — Appareil reproducteur féminin

L'impact d'un **fibrome** ou d'un **kyste** est significatif. La continuité avec les ligaments est primordiale.

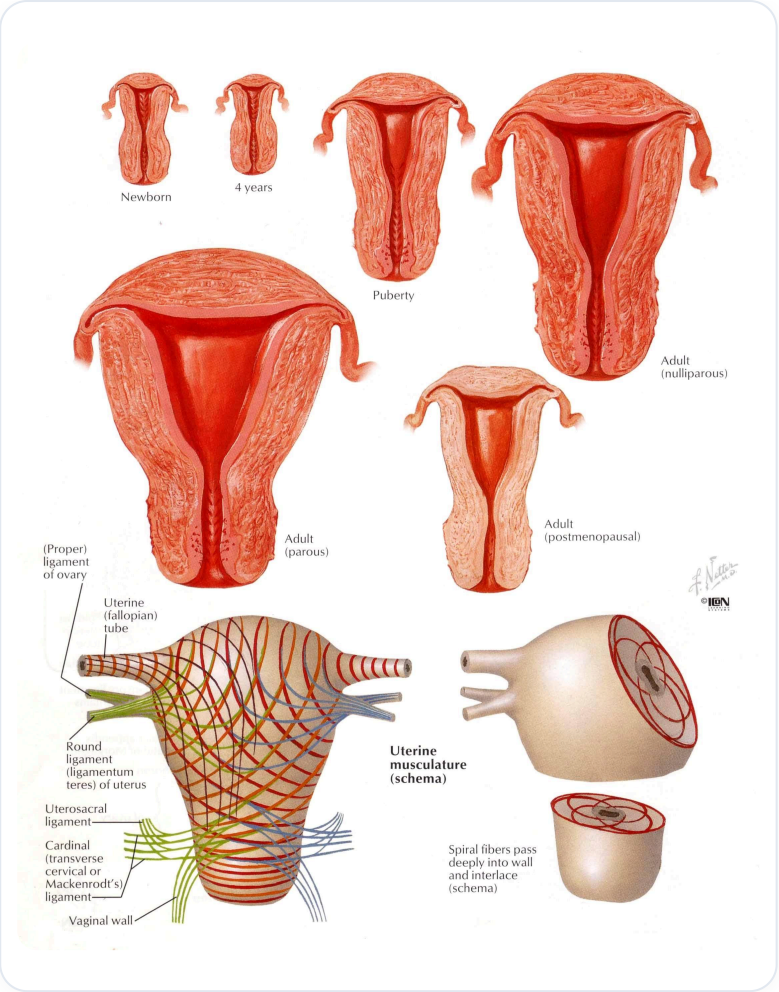


FIG. — Utérus et musculature

Lorsque l'on tire plus fort, on peut voir comment tout le système réagit, y compris les ligaments ronds.

Le péritoine est un tissu très intelligent. L'influence d'un fibrome, par exemple, peut modifier tout le système en aval par une simple traction.

Un gros fibrome peut entraîner une cascade de conséquences dans tout le système.

ral de Müller ouvert dans la cavité péritonéale devient le pavillon de la trompe (fig. 1 et 2).

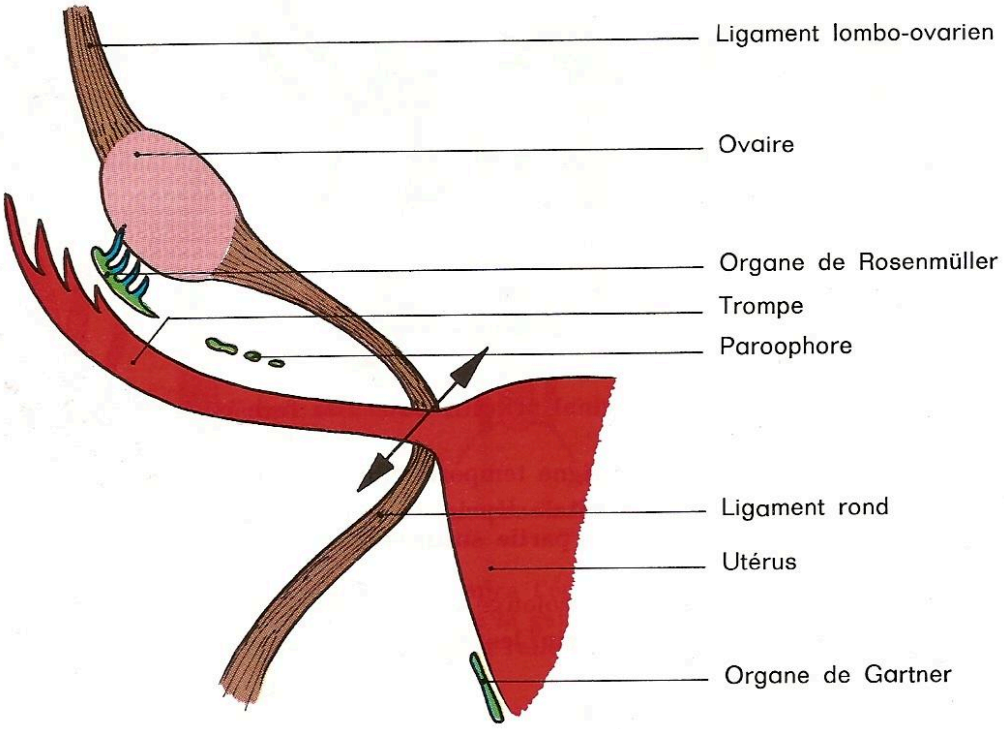
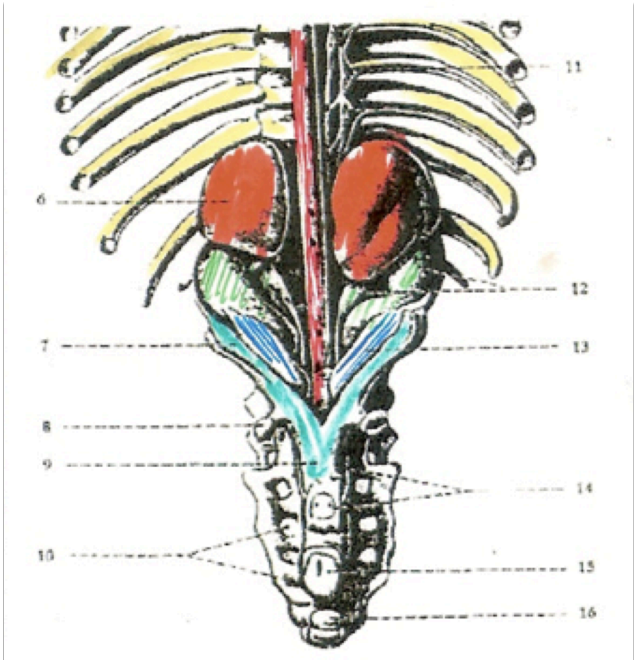


Fig. 1. — *Formation de la trompe et résidus wolffiens.*

FIG. — Organes génitaux féminins



6. Glandula suprarenalis
7. Müllerian duct
8. Lig.teres uteri
9. Uterus
10. For.sacralia ant.
11. Ramus communicans
12. Ren, Pelvis renalis
13. Ovarium
14. Urether
15. Anus
16. Anlage Os coccygis

FIG. — Appareil génital fœtal

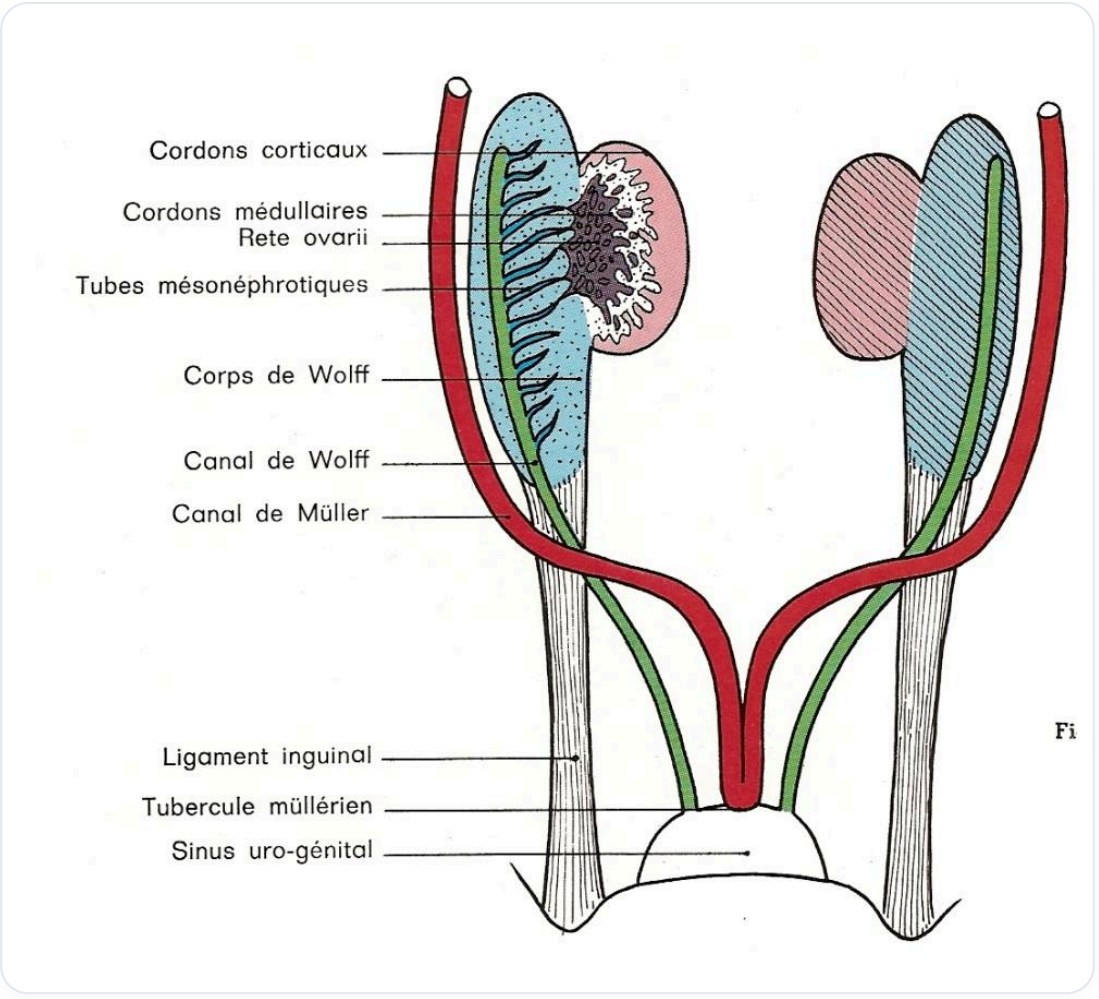


FIG. — Appareil génital indifférencié